PSICOLOGIA EM PAUTA EDIÇÃO ESPECIAL | AGOSTO 2026

ARTIGO DE OPINIÃO + REPORTAGEM DOCUMENTAL

Quem cuida de quem cuida?



Psicologia, SUS, SUAS e terceiro setor: identidade profissional, financiamento, precarização e caminhos para qualificar o cuidado em São Paulo.

Gabriel Batista
Psicólogo e Neuropsicólogo | CRP 06/176184

> **A pergunta central**
>
> Se uma política pública existe para proteger pessoas, a precarização de quem realiza esse cuidado pode ser tratada como simples problema administrativo?

“O crachá muda. A política pública muda. A finalidade institucional muda. A Psicologia não desaparece.”

Edição elaborada com dados públicos, legislação vigente, documentos institucionais e literatura científica. Atualização documental: 26 de agosto de 2026.

01 / COMO LER ESTA EDIÇÃO

Um editorial crítico, mas verificável

Este documento combina linguagem jornalística, apreciação crítica e revisão documental. Seu objetivo não é produzir uma auditoria de uma organização específica, nem afirmar que toda parceria com o terceiro setor resulte em precarização. A pergunta é estrutural: quais condições de financiamento, gestão do trabalho, reconhecimento profissional e proteção psicossocial ajudam ou atrapalham a qualidade do cuidado prestado por psicólogas e psicólogos nas políticas públicas?

A edição adota margens acadêmicas, sistema autor-data e referências organizadas em padrão ABNT, mas preserva uma diagramação editorial para facilitar a leitura. Dados municipais foram confrontados com normas de São Paulo; argumentos sobre trabalho e saúde foram apoiados por documentos do Conselho Federal de Psicologia e por estudos revisados por pares.

Quatro objetivos

- Explicar por que a Psicologia permanece uma profissão técnica, inclusive quando atua no SUAS e em OSCs.
- Mostrar como a rede socioassistencial paulistana depende de parcerias com OSCs e como o financiamento alcança o item recursos humanos.
- Documentar, com limites metodológicos explícitos, evidências sobre precarização, assédio, insegurança laboral e saúde mental dos trabalhadores do SUAS.
- Propor critérios de qualidade para poder público, OSCs, lideranças, recrutadores e para a própria categoria profissional.

> **Limite importante**
>
> Comparar orçamentos do SUS e do SUAS ajuda a visualizar escala, mas não demonstra, sozinho, “maior valorização” de uma política. Saúde inclui hospitais, medicamentos, exames, urgência e infraestrutura de alto custo. Nesta edição, a comparação é tratada como contexto, não como causalidade.

O que é fato, o que é interpretação

Fatos documentais aparecem acompanhados de fonte e data. Inferências são apresentadas como leitura crítica. Propostas aparecem em seções próprias. Quando um estudo tem amostra pequena, município específico ou dados antigos, isso é indicado. Essa separação é deliberada: crítica política ganha força quando não precisa exagerar a evidência.

02 / IDENTIDADE PROFISSIONAL

Psicologia é saúde. E também entende o humano em contexto.

A Resolução nº 287/1998 do Conselho Nacional de Saúde relaciona a Psicologia entre as categorias profissionais de saúde de nível superior (BRASIL, 1998). Isso é relevante para corrigir uma distorção frequente no mercado: a experiência de um psicólogo no SUAS não deixa de ser experiência psicológica apenas porque ocorreu fora de um equipamento sanitário.

Ao mesmo tempo, a atuação no SUAS não autoriza transformar assistência social em consultório. O foco institucional é a proteção social, a garantia de direitos, a autonomia, os vínculos, o território e o enfrentamento das vulnerabilidades. O ponto crítico está entre dois excessos: "clinificar" o social ou, no extremo contrário, reduzir o psicólogo a um técnico genérico de nível superior.

> **A distinção que importa**
>
> Interdisciplinaridade não é indiferenciação. Profissões diferentes precisam colaborar sem apagar seus núcleos de formação, seus limites éticos e as competências específicas que justificam a presença de cada uma na equipe.

Um problema reconhecido pela própria categoria

O relatório da III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS registra desafios ligados à identidade profissional, às condições de trabalho e à relação entre diferentes saberes dentro da política. O documento também discute a distância entre formação universitária e realidade do SUAS, além de vínculos precarizados e dificuldades de reconhecimento da especificidade psicológica (CFP, 2025).

Esse diagnóstico não deve alimentar uma disputa corporativa com o Serviço Social. A questão é outra: uma equipe multiprofissional só é verdadeiramente interdisciplinar quando consegue somar perspectivas sem transformar todas as formações em uma mesma função indistinta.

O melhor recrutamento não pergunta apenas "onde você trabalhou?". Pergunta "o que você aprendeu a fazer, com que complexidade e com quais responsabilidades?"

03 / PIA X PTS

Dois instrumentos, duas políticas, uma competência transversal

No SUAS, o Plano Individual de Atendimento (PIA) é utilizado em diferentes modalidades e normativas. Em São Paulo, documentos técnicos recentes o descrevem como instrumento de planejamento individualizado, construído com objetivos, ações, metas, prazos e responsabilidades, com participação do usuário, da família e da rede quando pertinente (SÃO PAULO, 2026a).

Na saúde, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) parte das necessidades singulares da pessoa e da família e pressupõe decisão compartilhada, articulação entre serviços e revisão do plano de cuidado segundo o modelo biopsicossocial (BRASIL, s.d.).

Eixo	PIA no SUAS	PTS na saúde
Finalidade institucional	Proteção social, direitos, autonomia, vínculos, território.	Cuidado em saúde, funcionalidade, autonomia, clínica ampliada.
Construção	Equipe de referência + usuário/família + rede, conforme o serviço.	Equipe de saúde + pessoa/família + pontos da rede de atenção.
Plano	Objetivos, ações, metas, prazos, responsabilidades.	Necessidades, objetivos de cuidado, responsabilidades e reavaliação.
O que não são	Não é diagnóstico clínico disfarçado.	Não é formulário fixo nem plano exclusivamente médico.
Competências transversais	Escuta, observação, formulação contextual, documentação, articulação de rede, monitoramento.	Escuta, avaliação, formulação clínica ampliada, documentação, articulação de rede, monitoramento.

Fonte: síntese editorial a partir de SMADS (2026) e Ministério da Saúde (s.d.). Os instrumentos não são equivalentes.

O ponto político

A existência de instrumentos distintos mostra justamente por que não é necessário escolher entre “Psicologia da saúde” e “Psicologia de humanas”. A mesma formação pode contribuir em políticas diferentes, desde que seu método seja ajustado à finalidade institucional, às normas do serviço e aos limites éticos da profissão.

04 / REPORTAGEM VISUAL

A política pública acontece onde as pessoas estão

As imagens abaixo não são apresentadas como prova estatística. Elas cumprem outra função jornalística: lembrar que rede, matriciamento, acolhimento e trabalho multiprofissional são atividades concretas, realizadas por equipes em ambientes reais. A identidade profissional se constrói também nesse cotidiano.



Registro de atendimento em serviço e trabalho articulado entre profissionais. Acervo do autor.



Registro de equipe multiprofissional em contexto de serviço público. Acervo do autor.

Uma fotografia não substitui uma pesquisa

Mas ela pode revelar o que as categorias abstratas escondem: política pública é feita por trabalhadores, relações, equipamentos, documentação, supervisão, decisões e condições materiais de trabalho.

05 / SÃO PAULO EM NÚMEROS

Uma cidade que cuida por uma rede fortemente parceirizada

No balanço do primeiro semestre de 2026, a SMADS informou que a rede paulistana contava com 1.387 serviços conveniados executados em parceria com 338 Organizações da Sociedade Civil, somando mais de 246 mil vagas. No mesmo período, os serviços de referência realizaram mais de 223 mil atendimentos, alcançando 187 mil pessoas (SÃO PAULO, 2026b).

338	1.387	> 246 mil	187 mil
OSCs parceiras	serviços conveniados	vagas ofertadas	pessoas alcançadas*

Fonte: SMADS, balanço do primeiro semestre de 2026. *Pessoas alcançadas pelos serviços de referência no período.

Esses números mudam a pergunta. OSC não é periferia administrativa da política: em São Paulo, é parte central da infraestrutura que sustenta a oferta socioassistencial. Por isso, qualidade da parceria, gestão do trabalho e saúde das equipes não podem ser tratadas como assuntos internos sem relação com o resultado público.

Nem vilãs, nem zonas sem responsabilidade

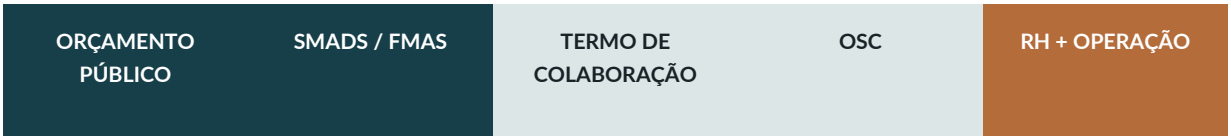
Há OSCs com longa trajetória técnica, equipes qualificadas e serviços complexos. Também há organizações que operam sob forte restrição financeira ou enfrentam problemas de governança. Uma análise responsável precisa rejeitar dois atalhos: demonizar toda organização parceira ou presumir que o poder público deixa de ser responsável pela qualidade do serviço quando assina um termo de colaboração.

> **Pergunta para a gestão pública**
>
> Se a rede depende de centenas de OSCs, qual é o sistema de qualidade que acompanha não apenas metas de atendimento e prestação de contas, mas também rotatividade, vacâncias, formação de lideranças, saúde do trabalhador e segurança psicossocial?

06 / FINANCIAMENTO

O repasse não chega ao trabalhador em linha reta

A Instrução Normativa SMADS nº 2/2024 mostra que o repasse mensal é estruturado por custos diretos e indiretos. Entre os custos diretos estão remuneração de recursos humanos, encargos sociais e trabalhistas, despesas impostas por lei ou convenções coletivas e fundo provisionado. A norma também determina que a remuneração conste no Plano de Trabalho, observe piso profissional e convenções aplicáveis, seja compatível com o mercado e respeite a planilha referencial do serviço (SÃO PAULO, 2024).



Fonte: Fluxo simplificado para fins didáticos. A execução real contém regras de planejamento, prestação de contas, remanejamentos e controles específicos.

Isso explica por que um salário baixo não pode ser atribuído automaticamente a uma única causa. Pode haver decisão inadequada da organização, parâmetro insuficiente da parceria, convenção coletiva aplicável, desenho de carreira inexistente, combinação desses fatores ou outras variáveis. A investigação responsável começa pela planilha de custos e pelas regras da tipologia, não pela acusação pronta.

A recomposição de RH é um sinal a ser lido

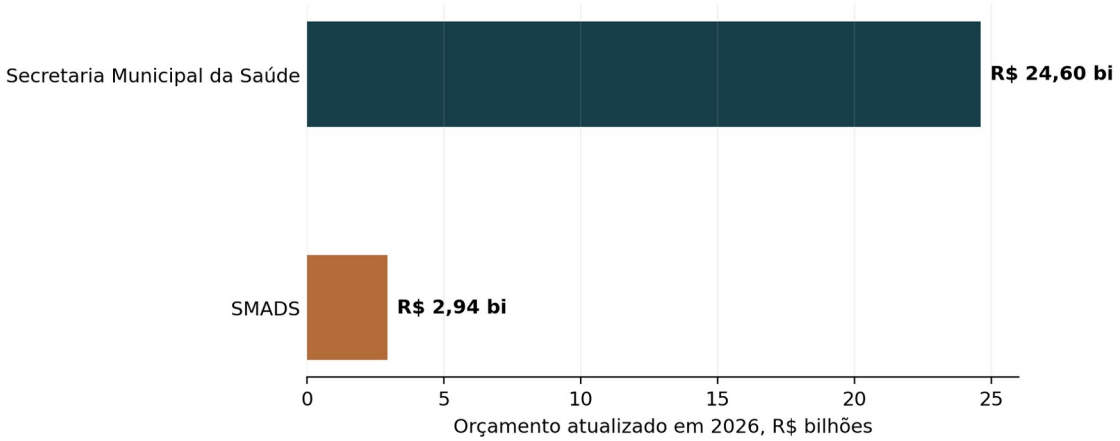
Em março de 2026, a Portaria SMADS nº 46 autorizou, em caráter excepcional, recomposição em parcela única de despesas do item “Remuneração de Recursos Humanos” em termos de colaboração com OSCs, abrangendo períodos de 2024 e 2025. Em julho, a Portaria nº 128 alterou regras e ampliou o prazo de utilização, mantendo prioridade para despesas de RH (SÃO PAULO, 2026c; 2026d).

> **O que esse fato permite afirmar**
>
> Houve necessidade administrativa concreta de recompor despesas de recursos humanos nas parcerias. Isso sustenta a existência de pressão financeira sobre esse componente do custeio. Não permite concluir, sozinho, que toda OSC esteja subfinanciada ou que toda remuneração seja inadequada.

07 / ESCALA ORÇAMENTÁRIA

Saúde e assistência operam em universos financeiros muito diferentes

Em maio de 2026, a Secretaria Municipal da Saúde informava orçamento atualizado de aproximadamente R$ 24,60 bilhões. A SMADS informava orçamento atualizado de aproximadamente R$ 2,94 bilhões, dos quais cerca de R$ 2,57 bilhões estavam no Fundo Municipal de Assistência Social (SÃO PAULO, 2026e; 2026f).



Escala orçamentária das duas secretarias em 2026, segundo páginas oficiais atualizadas em maio.

> **Não é uma comparação de "quem merece mais"**
>
> Hospitais, medicamentos, exames e estruturas sanitárias tornam a saúde estruturalmente mais cara. O gráfico não prova desvalorização do SUAS. Ele mostra a diferença de escala dentro da qual cada política precisa sustentar suas redes, equipes e compromissos.

A discussão relevante para esta edição é menos simplista: o valor disponível para assistência social consegue acompanhar a complexidade da rede, os reajustes de pessoal, a expansão de demandas, a qualificação das equipes e as exigências de gestão? A existência de grupos de trabalho do COMAS-SP sobre o orçamento de 2026 e as recomposições específicas de RH mostram que o tema permanece em disputa institucional.

A pergunta que os números não respondem sozinhos

Quanto custa manter uma equipe estável, treinada, supervisionada e protegida contra riscos psicossociais? Sem responder a isso, eficiência pode virar apenas sinônimo de fazer mais com uma equipe cada vez mais cansada.

08 / O QUE A PESQUISA ENCONTRA

Precarização não é apenas uma impressão de corredor

A literatura disponível não autoriza generalizações indiscriminadas, mas revela padrões recorrentes. Um levantamento nacional publicado por Sales e Maciel (2019), com 1.100 psicólogos das cinco regiões do país, descreveu baixa remuneração, jornadas extensas, fragilidades formativas e incertezas sobre papéis profissionais na assistência social.

Em estudo qualitativo com 12 psicólogas(os) que haviam trabalhado em serviços socioassistenciais terceirizados de um município do interior do Rio Grande do Sul, Brandolt et al. (2021) encontraram precarização atravessando seleção, contratos, carga horária, função, remuneração, educação permanente e encerramento dos vínculos, além de relações baseadas em medo e intimidação. A amostra é pequena e local, portanto deve ser lida como evidência qualitativa, não como estimativa nacional.

Pauli, Traesel e Siqueira (2019), ao entrevistar seis psicólogos temporários com experiência em CREAS, descreveram desgaste, frustrações, adoecimento, falta de valorização da gestão e insegurança quanto à renovação de contrato. Novamente, é um estudo local e qualitativo, útil para compreender mecanismos e experiências, não para medir prevalência.

Uma revisão crítica publicada por Amorim e Dalla Vecchia (2024) reuniu 17 trabalhos e organizou os achados em quatro eixos: características adoecedoras do trabalho, precarização, sofrimento dos trabalhadores e estratégias de enfrentamento. A convergência entre estudos de métodos e períodos distintos fortalece a necessidade de tratar saúde do trabalhador como questão de política pública.

Fonte	Desenho	O que acrescenta	Limite principal
Sales & Maciel, 2019	Survey, n=1.100	Panorama nacional de condições e identidade	Dados de período anterior
Brandolt et al., 2021	Qualitativo, n=12	Terceirização, medo, contrato e remuneração	Um município do RS
Pauli et al., 2019	Qualitativo, n=6	Desgaste, adoecimento e insegurança	Um CREAS / experiência temporária
Amorim & Dalla Vecchia, 2024	Revisão, 17 estudos	Síntese de sofrimento e precarização no SUAS	Heterogeneidade dos estudos

09 / SAÚDE DE QUEM CUIDA

Assédio não é “perfil forte de liderança”

O relatório da III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS, publicado pelo CFP em 2025, reúne relatos e debates sobre precarização, assédio moral, equipes reduzidas, salários incompatíveis com responsabilidades técnicas, carga horária, infraestrutura inadequada e ausência de educação permanente. O documento também ressalta que instituições devem promover saúde, dignidade e segurança no trabalho (CFP, 2025).

No campo regulatório, a NR-1 passou a incluir expressamente fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais. A nova redação do capítulo 1.5 entrou em vigor em 26 de maio de 2026, e materiais oficiais citam sobrecarga e assédio entre exemplos de fatores relacionados à organização do trabalho (BRASIL, 2026a).

> **Atualização jurídica de 2026**
>
> Em 25 de junho de 2026, o STF suspendeu por 90 dias multas e outras sanções ligadas à inclusão desses fatores na NR-1 enquanto buscava conciliação sobre critérios de aplicação. A suspensão de sanções não transforma assédio, sobrecarga ou gestão inadequada em riscos irrelevantes. Ela exige apenas cuidado ao descrever o estado regulatório (BRASIL, 2026b).

O paradoxo institucional

Uma organização pode defender direitos humanos em seu projeto institucional e ainda reproduzir relações autoritárias dentro da equipe. Pode oferecer acolhimento ao território e produzir medo nos trabalhadores. Pode promover saúde mental para usuários e tratar sofrimento ocupacional como fraqueza individual. É justamente por isso que valores institucionais precisam ser traduzidos em processos de gestão verificáveis.

Não basta treinar quem atende

- Lideranças precisam ser treinadas em feedback, gestão de conflitos, distribuição de carga, prevenção ao assédio e limites da autoridade administrativa.
- Equipes expostas a alta complexidade precisam de supervisão técnica e espaços de elaboração do trabalho, não apenas palestras eventuais.
- Canais de denúncia precisam ter proteção contra retaliação, fluxo definido, rastreabilidade e devolutiva.
- Rotatividade, afastamentos, vacâncias e clima de equipe devem ser tratados como indicadores de qualidade do serviço.

10 / SALÁRIO, JORNADA E PROTEÇÃO

A desvalorização também aparece no que ainda não virou direito nacional

Até 26 de agosto de 2026, a Psicologia não possui piso salarial nacional em vigor. O PL nº 1.551/2026 propõe R$ 4.500 mensais para jornada de até 30 horas semanais, mas segue em tramitação na Câmara dos Deputados e aguarda relatoria na Comissão de Saúde. O PL nº 2.805/2026 foi apensado à proposta (BRASIL, 2026c).

A jornada nacional de até 30 horas para psicólogos também permanece em tramitação. O PL nº 1.214/2019 foi aprovado na Câmara e chegou ao Senado em julho de 2026, onde aguardava despacho na última atualização oficial consultada (BRASIL, 2026d).

Para comparação institucional, assistentes sociais possuem jornada legal de 30 horas desde a Lei nº 12.317/2010. A comparação não pretende opor categorias: mostra que profissionais que frequentemente trabalham lado a lado no SUAS podem estar submetidos a proteções legais diferentes (BRASIL, 2010).

Um parâmetro do setor saúde em São Paulo

Na Convenção Coletiva SinPsi-SP/SindHosp 2025-2026, dentro de sua abrangência específica, o salário normativo para psicólogos foi fixado em R$ 4.338,84 a partir de setembro de 2025 e em R$ 4.423,05 a partir de dezembro de 2025. Esse valor não é piso nacional e não deve ser transferido automaticamente para contratos socioassistenciais, mas funciona como referência concreta de negociação coletiva no setor saúde paulista (SINPSI-SP; SINDHOSP, 2025).

R$ 4.500	30 h	R$ 4.423,05
piso proposto no PL 1551/2026	jornada proposta no PL 1214/2019	salário normativo na CCT saúde*

Fonte: *CCT SinPsi-SP/SindHosp 2025-2026, dentro da abrangência definida no instrumento. Projetos de lei não são direitos vigentes.

> **Salário é necessário, mas não suficiente**
>
> Remuneração digna não corrige sozinha sobrecarga, assédio, falta de supervisão, equipe incompleta ou ausência de carreira. Precarização é um fenômeno multidimensional.

11 / RECRUTAMENTO | MOBILIDADE

Quando “veio do SUAS” vira um rótulo que empobrece o currículo

Experiência setorial importa. Uma vaga hospitalar pode exigir conhecimento de rotinas hospitalares; um CAPS exige familiaridade com RAPS; um CRAS ou CREAS exige domínio da política socioassistencial. O problema surge quando o setor de origem substitui a análise das competências desenvolvidas.

Um psicólogo que trabalhou no SUAS pode ter desenvolvido competências avançadas em violência, deficiência, vínculos, trabalho com famílias, grupos, crise, autonomia, articulação intersetorial, documentação técnica e leitura de fatores sociais associados ao sofrimento. Essas competências não tornam o profissional automaticamente preparado para qualquer vaga na saúde, mas tampouco desaparecem na mudança de política pública.

Uma matriz de seleção mais inteligente

Competência	Pergunta de seleção baseada em evidência
Formulação de caso	Consegue integrar história, comportamento, contexto, riscos e recursos sem reduzir a pessoa a uma etiqueta?
Trabalho em rede	Articula saúde, assistência, educação, justiça e território com clareza de responsabilidades?
Documentação	Produz registros e relatórios tecnicamente adequados, objetivos e éticos?
Interdisciplinaridade	Consegue sustentar sua contribuição psicológica sem invadir atribuições de outras profissões?
Gestão de risco	Reconhece situações que exigem escalonamento, encaminhamento ou proteção imediata?
Aprendizagem setorial	Demonstra capacidade de aprender protocolos e fluxos do novo serviço?

> **O princípio**
>
> Contratar por competência não significa ignorar experiência específica. Significa evitar que “setor de origem” funcione como atalho para presumir o que o candidato sabe ou não sabe fazer.

12 / AGENDA DE QUALIDADE

Dez mudanças possíveis para qualificar OSCs e proteger trabalhadores

1. Financiamento previsível Revisar planilhas de custo e mecanismos de reajuste com foco explícito em RH, encargos e retenção de profissionais.

2. Transparência remuneratória Publicar parâmetros de composição de RH por tipologia e tornar mais legível o que é custo do serviço, salário, encargos e fundo provisionado.

3. Formação obrigatória de lideranças Capacitar gerentes e coordenadores em gestão de pessoas, comunicação, conflitos, ética, assédio e riscos psicossociais.

4. Supervisão técnica Prever espaços regulares de supervisão e educação permanente para equipes expostas a alta complexidade.

5. Canal protegido de denúncia Criar fluxo independente, prazo de resposta, proteção contra retaliação e governança de casos de assédio.

6. Indicadores de gente Monitorar rotatividade, vacância, afastamentos, horas extras, tempo de permanência, acidentes e sinais de sobrecarga.

7. Fiscalização de qualidade do trabalho Incluir condições de trabalho e estabilidade de equipe na avaliação da parceria, não apenas execução financeira e volume de atendimentos.

8. Identidade profissional clara Definir atribuições de psicólogo, serviço social e demais categorias de modo complementar, evitando “técnico genérico” como solução para qualquer demanda.

9. Recrutamento por competências Avaliar competências transferíveis entre SUS, SUAS e terceiro setor, sem dispensar formação para especificidades do novo equipamento.

10. Participação dos trabalhadores Criar mecanismos regulares para que as equipes influenciem melhorias de processo, formação e prevenção de riscos.

> **A lógica da proposta**
>
> Não se trata de acrescentar burocracia ornamental. Trata-se de reconhecer que gestão do trabalho é parte da tecnologia de cuidado. Uma equipe adoecida, instável ou amedrontada não é um problema “de RH” separado da qualidade assistencial.

13 / QUADRO DE EVIDÊNCIAS

O que esta edição consegue sustentar, e até onde

Afirmação	Base documental	Limite de interpretação
Psicologia é reconhecida como profissão de saúde	Resolução CNS nº 287/1998.	Fato normativo. Não significa que toda atuação psicológica tenha finalidade sanitária.
A rede socioassistencial paulistana depende fortemente de OSCs	338 OSCs e 1.387 serviços conveniados no balanço do 1º semestre de 2026.	Retrato de um período; a rede pode mudar.
RH é componente estruturado do custeio das parcerias	IN 02/SMADS/2024 e Portarias 46/2026 e 128/2026.	Mostra regras e recomposição; não prova insuficiência em cada serviço.
Há evidências de precarização e sofrimento no trabalho do SUAS	CFP 2025, estudos de 2019 e 2021, revisão de 2024.	Estudos diferem em amostras, locais e desenhos; convergência é mais forte que qualquer estudo isolado.
Riscos psicossociais ganharam centralidade regulatória	NR-1 atualizada e materiais oficiais do MTE; decisão do STF sobre sanções.	Estado jurídico é dinâmico e deve ser checado antes de uso jurídico ou fiscal.
Psicologia ainda busca piso e jornada nacional	PL 1551/2026 e PL 1214/2019 em tramitação.	Projetos não geram direito vigente enquanto não concluído o processo legislativo.

Por que isso importa

O objetivo de uma apreciação crítica não é transformar correlação em prova ou opinião em estatística. É organizar evidências suficientes para formular perguntas melhores. Neste caso, as fontes permitem sustentar que identidade profissional, financiamento, gestão do trabalho e saúde ocupacional são dimensões inseparáveis da qualidade da proteção social.

14 / CONCLUSÃO

Quem cuida de quem cuida?

A resposta não pode ser apenas “o próprio profissional”. Autocuidado não corrige subfinanciamento. Resiliência não substitui equipe suficiente. Uma palestra não corrige assédio. Supervisão não compensa indefinidamente uma organização do trabalho adoecedora. E vocação não é política salarial.

Também seria simplista responsabilizar apenas as OSCs. Em uma rede baseada em termos de colaboração, poder público e organização parceira compartilham responsabilidades diferentes, mas conectadas. O município define parâmetros, regula, financia e fiscaliza. A OSC administra, contrata, lidera e executa. O trabalhador materializa a política na relação cotidiana com o usuário.

A Psicologia precisa fazer sua parte. Defender identidade profissional não significa transformar o SUAS em extensão da clínica, disputar território com o Serviço Social ou reivindicar privilégio. Significa conseguir explicar o que a formação psicológica acrescenta à proteção social e sustentar essa contribuição com método, ética e trabalho interdisciplinar.

O sujeito é biopsicossocial antes de qualquer organograma.

Não deixa de ter corpo quando entra no SUAS. Não deixa de ter história social quando entra no SUS. Não abandona vínculos, cognição, comportamento, cultura, renda ou território na porta de nenhum equipamento. As políticas precisam de fronteiras administrativas; o cuidado precisa de pontes técnicas.

Talvez o próximo passo para amadurecer a relação entre Estado, terceiro setor e Psicologia seja mudar a pergunta. Não apenas quantos profissionais conseguimos colocar na ponta, mas que condições oferecemos para que profissionais qualificados desejem permanecer nela, aprender nela e cuidar bem durante anos.

> **Síntese editorial**
>
> Uma política pública que depende de trabalhadores qualificados precisa tratar o trabalho como parte do cuidado. Valorizar a Psicologia no SUAS não é afastá-la das Humanidades nem transformá-la em clínica: é reconhecer a capacidade de compreender pessoas em contextos complexos, com responsabilidade técnica e em diálogo com outras profissões.

15 / REFERÊNCIAS

Referências e documentação de apoio

Referências organizadas em padrão ABNT adaptado para publicação editorial. Acesso aos conteúdos eletrônicos em 26 ago. 2026, salvo indicação em contrário.

AMORIM, Noelle Lopes; DALLA VECCHIA, Marcelo. Saúde Mental do Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social: revisão crítica da literatura. Estudos de Psicologia (Natal), v. 29, 2024. DOI: 10.69909/1678-4669.20240006. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-294X2024000100801&script=sci_arttext.

BRANDOLT, Catheline Rubim; COELHO-LIMA, Fellipe; MOTTA, Roberta Fin; SANTOS, Samara Silva dos. Condições de trabalho de psicólogas(os) resultantes do processo de terceirização na assistência social. Psicologia & Sociedade, v. 33, e229301, 2021. DOI: 10.1590/1807-0310/2021v33229301.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 1.551, de 2026. Institui piso salarial nacional da profissão de psicólogo. Brasília, DF, 2026. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2612948.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 287, de 8 de outubro de 1998. Relaciona categorias profissionais de saúde de nível superior. Brasília, DF, 1998. Disponível em: https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/1998/resolucao-no-287.pdf/view.

BRASIL. Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010. Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662/1993 para dispor sobre a duração do trabalho do assistente social. Brasília, DF: Presidência da República, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12317.htm.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. NOB-RH/SUAS: anotada e comentada. Brasília, DF: MDS, 2011. Disponível em: https://mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/NOB-RH_SUAS_Anotada_Comentada.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. Projeto Terapêutico Singular. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/autismo/pts.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1): Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília, DF, 2026a. Atualizado em 6 ago. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-1.

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 1.214, de 2019. Fixa a duração do trabalho do psicólogo em até 30 horas semanais. Brasília, DF, 2026d. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/175233.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. STF suspende sanções da NR-1 e abre conciliação sobre regras de riscos psicossociais no trabalho. Brasília, DF, 25 jun. 2026b. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-suspende-sancoes-da-nr-1-e-abre-conciliacao-sobre-regras-de-riscos-psicossociais-no-trabalho/.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS: práxis e reverberações. Brasília, DF: CFP, 2025. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2025/06/relatorio_mostra_suas_web_2.pdf.

PAULI, Cassiele Gomes; TRAESEL, Elisete Soares; SIQUEIRA, Aline Cardoso. A precarização do trabalho dos psicólogos temporários no CREAS. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 39, e188301, 2019. DOI: 10.1590/1982-3703003188301.

SALES, Allana Ribeiro Porto; MACIEL, Regina Heloisa. A atuação do psicólogo na assistência social brasileira. Temas em Psicologia, v. 27, n. 1, p. 233-247, 2019. DOI: 10.9788/TP2019.1-17.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Instrução Normativa nº 2, de 15 de março de 2024. Dispõe sobre parcerias com Organizações da Sociedade Civil no âmbito da SMADS. São Paulo, 2024. Disponível em: https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-2-de-15-de-marco-de-2024.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Nota Técnica nº 1, de 17 de julho de 2026. Orientações técnicas e instrumentalização do Plano Individual de Atendimento. São Paulo, 2026a. Disponível em: https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/nota-tecnica-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-1-de-17-de-julho-de-2026/consolidado.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Balanço semestral da rede socioassistencial: principais resultados na metade do ano. São Paulo, 2026b. Disponível em:

https://prefeitura.sp.gov.br/web/popruasp/w/balan%C3%A7o-semestral-da-rede-socioassistencial-saiba-os-principais-resultados-da-pasta-na-metade-do-ano.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Portaria nº 46, de 30 de março de 2026. Autoriza recomposição excepcional de despesas com remuneração de recursos humanos em termos de colaboração. São Paulo, 2026c. Disponível em: https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/portaria-46-de-3-de-abril-de-2026.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Portaria nº 128, de 30 de julho de 2026. Altera a Portaria nº 46/SMADS/2026. São Paulo, 2026d. Disponível em: https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/portaria-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-128-de-30-de-julho-de-2026.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Ações e Programas: Orçamento 2026. São Paulo, 2026e. Atualização: maio 2026. Disponível em: https://smartsampa.prefeitura.sp.gov.br/web/assistencia_social/w/acesso_a_informacao/178373.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal da Saúde. Ações e Programas: Orçamento 2026. São Paulo, 2026f. Atualização: 5 maio 2026. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/saude/w/acesso_a_informacao/acoes-e-programas.

SINPSI-SP; SINDHOSP. Convenção Coletiva de Trabalho 2025-2026: psicólogos. São Paulo, 2025. Cláusula 3ª - salário normativo. Disponível em: https://sinpsi.org/wp-content/uploads/2025/10/CCT-PSICOLOGOS-2025-2026-SINDHOSP.pdf.

Nota editorial e ética

Esta publicação é uma apreciação crítica e educativa. Não substitui parecer jurídico, auditoria de parceria, fiscalização trabalhista, orientação sindical ou análise individual de condições de trabalho. Não atribui irregularidades a nenhuma OSC específica. Fotografias são utilizadas como registros de contexto profissional e não identificam pessoas ou instituições no texto. Dados e estados legislativos refletem as fontes consultadas até 26 de agosto de 2026.

PSICOLOGIA EM PAUTA

Edição especial 2026
Trabalho, políticas públicas e terceiro setor

Gabriel Batista

Psicólogo e Neuropsicólogo
CRP 06/176184